研修医向け・20 分

健康の社会的決定要因と慢性疾患リスク

参考文献

2026-05-14 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

あなたの患者さん、なぜコントロール不良のまま？

外来で2型糖尿病のHbA1cがなかなか下がらない患者がいる。
薬は処方している。指導もしている。でも改善しない。
何を見落としているかもしれないか？

PART 1

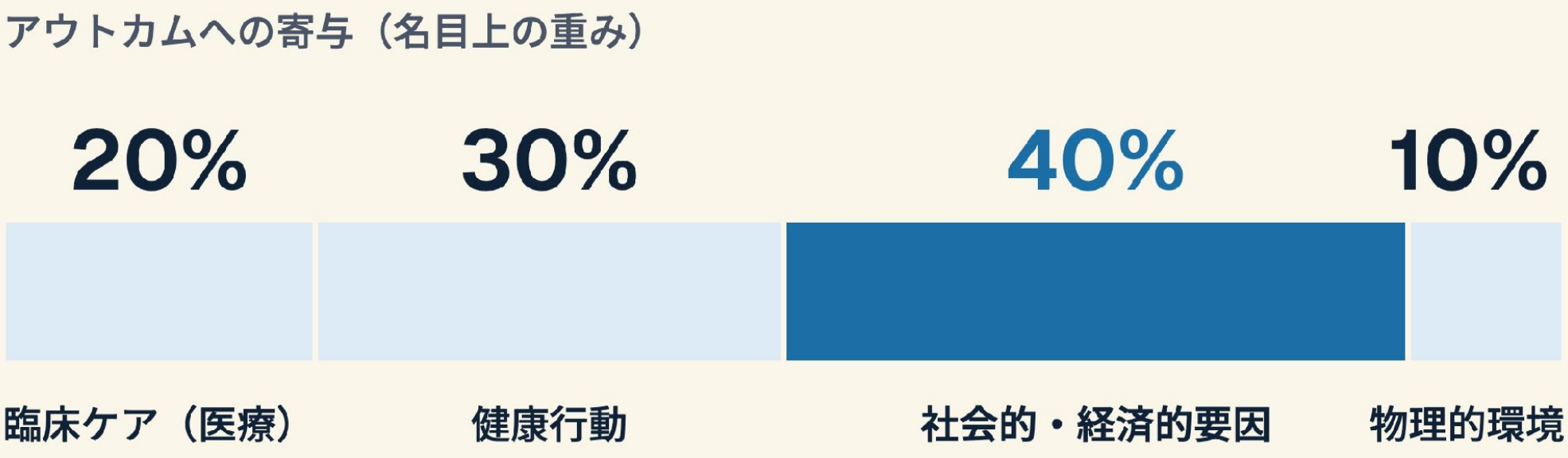
症例から考える

症例: 58歳女性、2型糖尿病 HbA1c 9.2%

- 内服アドヒアランスは「問題なし」
- 食事指導は毎回実施
- しかし…
  - 食料品店まで車で40分
  - 近所のコンビニが主な食料源
  - 公共交通なし、受診コストが高い

「食事指導」は届いていたか？

健康アウトカムを決めるのは何か



「診察室の中」だけでは限界がある

出典: County Health Rankings 旧モデル（2025年に新モデルへ更新）の名目上の重み。
実際の寄与率を測った値ではない

健康の社会的決定要因(SDH)とは

SDH(Social Determinants of Health)= 人の健康に影響を与える社会的・経済的・環境的条件

- **住居** — 安定性、過密、環境有害物質
- **食** — 食料安全保障、食アクセス
- **交通** — 受診の可否、移動能力
- **経済** — 収入、雇用、経済的安定性
- **社会的サポート** — 孤立、コミュニティのつながり
- **教育** — リテラシー、ヘルスリテラシー

PART 2

All of Us 研究のエビデンス

PART 2・All of Us 研究のエビデンス

26万人の研究が示したこと

All of Us Research Program のデータを用いた予測研究（medRxiv 2026・査読前）

- n = 259,186人（参加者の自己申告データ）
- 12のSDH領域と慢性疾患（メンタルヘルス群・心代謝群）との関係を機械学習で分析
- 比較対象: 人口統計学的因子（年齢・性別・人種/民族など）。臨床検査値との比較ではない

主要結果:

> *予測精度は、SDHのみのモデルが人口統計のみのモデルと**同程度かそれ以上**（メンタルヘルス AUC 0.678 vs 0.655、心代謝 0.633 vs 0.636）*

データを読む: 何がわかったか

- 「どのSDHが何の疾患に効くか」は疾患群によって異なっていた
- メンタルヘルス群: ストレス・差別・宗教/スピリチュアリティが影響の大きい領域
- 心代謝群: 年齢・近隣の荒廃・差別が主な予測因子
- 著者らは、一律の問診票より**疾患別のスクリーニング**が望ましいと解釈している(スクリーニングの効果を直接検証した研究ではない)

PART 2・All of Us 研究のエビデンス

研究を批判的に見る

観点	評価
サンプルサイズ	n=259,186 と大規模
対象集団	米国の参加者コホート(日本への外挿に注意)
研究デザイン	自己申告データによる予測モデル。因果の解釈には限界あり
プレプリント	medRxiv段階(査読前)— まだ確定ではない

「約80%は臨床ケア以外」は旧モデルの名目上の重みから出る数字で、実測値ではない。数字の一人歩きに注意

疾患別に考えるとは(著者らの提案と実務上の例)

全疾患一律スクリーニング

(例: 全患者にSDH問診票)

懸念されること

スクリーニング負荷が大きい

陽性でも介入リソースが分散する

疾患別に絞る場合の例

(この研究の結果ではなく、実務上の工夫)

糖尿病患者	食アクセス + 交通
高血圧患者	住居安定性 + 経済的ストレス

リソースを必要な人に集中しやすくなる

PART 3

社会的処方（Social Prescribing）

PART 3・社会的処方(Social Prescribing)

社会的処方とは

薬や手術ではなく、**社会資源・コミュニティへのつなぎ**を「処方」する

- リンクワーカー(地域コーディネーター)が患者を地域資源に橋渡し
- 食品バンク、移動支援、就労支援、居場所づくり
- 英国NHSでは2019年のNHS長期計画以降、リンクワーカーの配置を推進

社会的処方そのものの効果は、今回の研究では検証されていない

日本の文脈で考える

日本でのSDH対応の現状と課題:

- 特定健診での社会的背景把握は限定的
- 在宅医療・ケアマネジャーとの連携が一部の施設で実践
- 特定健診へのSDH項目の追加は、2026年11月時点で正式な決定を確認できない

あなたの職場でできる「今すぐ1歩」は何か？

PART 4

臨床応用を考える

あなたの外来でできること

SDHスクリーニングを生活習慣病フォローに組み込む:

1. **食のアクセス**:「近くにスーパーはありますか？主にどこで買い物しますか？」
2. **交通・移動**:「受診に困ることはありますか？来るのに時間・お金はかかりますか？」
3. **経済的安定**:「処方薬の費用が負担になることはありますか？」
4. **住居**:「今の住まいで困っていることはありますか？」

スクリーニングから介入へ

陽性をどう活かすか:

- **院内連携**: MSW(医療ソーシャルワーカー)への紹介
- **地域連携**: ケアマネジャー、行政窓口、食支援NPO
- **制度活用**: 生活保護・障害年金・介護保険の確認
- **記録**: EHRへのSDH情報記録(未来の医師・スタッフへの継承)

「医師が全部やる」ではなく「チームでつなぐ」

PART 4・臨床応用を考える

ディスカッション（5分）

ペアで話し合ってください:

あなたの外来に、コントロール不良の慢性疾患患者がいるとします。

SDHの視点で「見直したいこと」を1つ挙げるとしたら？

（5分後に2グループで共有）

実践の障壁と対処

よくある声と返し:

障壁	対処
「時間がない」	2問の簡易スクリーニングから始める
「解決策がない」	MSW・ケアマネに紹介するだけでOK
「医師の仕事ではない」	診療の質に関わる情報として位置づける
「患者が嫌がる」	「お体以外で心配なことはありますか？」の一言から

PART 5

まとめ

PART 5・まとめ

今日の3つのメッセージ

1. **SDHは、慢性疾患の予測で人口統計学的因子と同程度に寄与しうる**（26万人の予測研究・査読前）
2. **疾患別のスクリーニングが望ましいと著者らは提案**（効果の検証はこれから）
3. **社会的処方は、効果を確かめながら試す価値のある介入**（配慮や優しさだけでなく、根拠を積む段階）

持ち帰りの問い

今日の勉強会を終えて、あなたに問います:

> *「あなたのチームで、SDHスクリーニングを1つ導入するとしたら、何から始めますか？」*

よければ、来週の外来で患者に1つだけ聞いてみてください。

参考文献

1. Kammer-Kerwick M, Dave Y, Parekh V, McDonald L, Watkins SC. Social Determinants of Health and Chronic Disease Risk Prediction in the All of Us Research Program. medRxiv 2026(査読前プレプリント). https://doi.org/10.64898/2026.03.19.26348851

2. Abdalla SM, Galea S. Embracing complexity and innovation to tackle the social determinants of health(解説論文). BMJ Global Health 2026. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12931545/

参考文献